

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Đề xa tâm tấy trẻ em

Thành phần công thức cho 1 viên:

Thành phần hoạt chất:
Mỗi viên AGILECOX 200 chứa 200 mg Celecoxib.
Thành phần tá dược:
Lactose monohydrat, Povidon K30, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat.

Dạng bào chế: Viên nang cứng cỡ số 2, nắp màu trắng viền vàng, thân màu trắng viền vàng, bên trong chứa bột thuốc tơi xốp màu trắng.

Chỉ định:

Celecoxib được chỉ định ở người lớn để giảm triệu chứng trong điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp và viêm cột sống dính khớp.
Quyết định kê toa thuốc ức chế chọn lọc cyclooxygenase-2 (COX-2) phải dựa trên đánh giá nguy cơ theo tình trạng của từng bệnh nhân (xem phần Chống chỉ định và Cảnh báo và thận trọng).

Cách dùng, liều dùng:

Cách dùng: Thuốc dùng đường uống.
Liều 200 mg/lần, ngày uống 2 lần, có thể uống không cần chú ý đến bữa ăn; liều cao hơn (400 mg/lần, ngày uống 2 lần) phải uống vào bữa ăn (cùng với thức ăn) để cải thiện hấp thu.
Liều dùng: Thuốc dùng cho người lớn.

Vì nguy cơ tim mạch của celecoxib có thể tăng theo liều lượng và thời gian dùng thuốc, nên dùng liều hiệu quả thấp nhất trong thời gian điều trị ngắn nhất có thể. Cần đánh giá định kỳ liều dùng đáp ứng với điều trị của bệnh nhân, đặc biệt là ở bệnh nhân viêm xương khớp.

Viêm xương khớp

Liều khuyến cáo hàng ngày thông thường là 200 mg uống một lần mỗi ngày. Ở một số bệnh nhân, nếu chưa giảm nhẹ các triệu chứng, có thể tăng liều 200 mg x 2 lần/ngày. Trường hợp sau hai tuần điều trị không hiệu quả, nên xem xét lựa chọn điều trị khác.

Viêm khớp dạng thấp

Liều khuyến cáo hàng ngày ban đầu là 200 mg uống một lần mỗi ngày. Nếu cần thiết, sau đó có thể tăng liều lên đến 200 mg x 2 lần/ngày. Trường hợp sau hai tuần điều trị không hiệu quả, nên xem xét lựa chọn điều trị khác.

Viêm cột sống dính khớp

Liều khuyến cáo hàng ngày là 200 mg uống một lần mỗi ngày. Ở một số bệnh nhân, nếu chưa giảm triệu chứng, có thể tăng liều 400 mg một lần mỗi ngày hoặc 200 mg x 2 lần/ngày có thể làm tăng hiệu quả. Trường hợp sau hai tuần điều trị không hiệu quả, nên xem xét lựa chọn điều trị khác.

Liều khuyến cáo tối đa hàng ngày là 400 mg cho tất cả các chỉ định.

Đối tượng đặc biệt

Người cao tuổi

Dùng như người lớn, khởi đầu nên dùng liều 200 mg mỗi ngày. Nếu cần thiết, sau đó có thể tăng lên đến 200 mg x 2 lần/ngày. Đặc biệt nên thận trọng ở người cao tuổi có trọng lượng cơ thể dưới 50 kg.

Trẻ em

Celecoxib không được chỉ định dùng cho trẻ em.

Những người chuyển hóa kém qua CYP2C9

Những bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ chuyển hóa kém qua CYP2C9 dựa trên tiền sử/kinh nghiệm với các cơ chất CYP2C9 khác cần thận trọng khi dùng celecoxib vì nguy cơ tác dụng không mong muốn phụ thuộc vào liều gia tăng. Bắt đầu điều trị với liều bằng ½ liều khuyến cáo thấp nhất.

Suy gan

Điều trị nên được bắt đầu bằng một nửa liều khuyến cáo ở bệnh nhân suy gan với albumin huyết thanh 25 - 35 g/l.

Kinh nghiệm ở những bệnh nhân này chỉ giới hạn ở bệnh nhân xơ gan.

Suy thận

Kinh nghiệm với celecoxib ở bệnh nhân suy thận nhẹ hoặc trung bình còn hạn chế, do đó bệnh nhân nên được điều trị thận trọng.

Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng thuốc:

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với celecoxib hoặc sulfonamid hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Đang bị loét dạ dày hoặc xuất huyết tiêu hóa.

Tiền sử bị hen, mày đay, hoặc các phản ứng kiểu dị ứng khác sau khi uống aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác (NSAIDs) bao gồm thuốc ức chế COX-2.

Trong thai kỳ và ở phụ nữ có khả năng sinh đẻ trừ khi sử dụng phương pháp tránh thai hiệu quả. Celecoxib đã được chứng minh là gây ra dị tật ở hai loài động vật được nghiên cứu. Tiềm năng nguy cơ của con người trong thai kỳ chưa được biết, nhưng không thể loại trừ.

Phụ nữ đang cho con bú.

Rối loạn chức năng gan nặng (albumin huyết thanh < 25 g/l hoặc điểm Child-Pugh ≥ 10).

Bệnh nhân có độ thanh thải creatinin ước tính < 30 ml/phút.

Bệnh viêm ruột.

Suy tim sung huyết (NYHA II-IV).

Bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh động mạch ngoại biên và/hoặc bệnh mạch máu não.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Các tác động trên đường tiêu hóa:

Biến chứng đường tiêu hóa trên và dưới (thủng, loét hoặc chảy máu), một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong, đã xảy ra ở những bệnh nhân dùng điều trị bằng celecoxib. Thận trọng khi điều trị ở những bệnh nhân có nguy cơ cao bị biến chứng đường tiêu hóa với NSAID như: Người cao tuổi, bệnh nhân đang dùng đồng thời bất kỳ NSAID khác hoặc acid acetylsalicylic hoặc glucocorticoid, bệnh nhân sử dụng rượu, hoặc bệnh nhân có tiền sử bệnh đường tiêu hóa, chẳng hạn như loét và chảy máu đường tiêu hóa.

Tăng nguy cơ tác dụng phụ đường tiêu hóa do celecoxib (loét đường tiêu hóa hoặc các biến chứng đường tiêu hóa khác), khi celecoxib được dùng đồng thời với acid acetylsalicylic (ngay cả ở liều thấp).

Sự khác biệt đáng kể về độ an toàn đường tiêu hóa giữa các chất ức chế chọn lọc COX-2 + acid acetylsalicylic so với NSAID + acid acetylsalicylic chưa được chứng minh trong các thử nghiệm lâm sàng dài hạn.

Dùng đồng thời NSAID:

Nên thận trọng đồng thời celecoxib với một thuốc NSAID không phải aspirin.

Các tác động trên tim mạch:

Nguy cơ huyết khối tim mạch:

Celecoxib có thể gây tăng nguy cơ huyết khối tim mạch nghiêm trọng, nhồi máu cơ tim, và đột quỵ, những biến cố này có thể gây tử vong.

Các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), không phải aspirin, dùng đường toàn thân, có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến cố huyết khối tim mạch, bao gồm cả nhồi máu cơ tim và đột quỵ, có thể dẫn đến tử vong. Nguy cơ này có thể xuất hiện sớm trong vài tuần đầu dùng thuốc và có thể tăng lên theo thời gian dùng thuốc. Nguy cơ huyết khối tim mạch được ghi nhận chủ yếu ở liều cao.

Bác sỹ cần đánh giá định kỳ sự xuất hiện của các biến cố tim mạch, ngay cả khi bệnh nhân không có các triệu chứng

bệnh nhân cao tuổi) khi thuốc ức chế men chuyển, thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, và/hoặc thuốc lợi tiểu được kết hợp với NSAID, bao gồm celecoxib. Vì vậy, sự kết hợp nên được dùng thận trọng, đặc biệt là ở người cao tuổi. Cần cho bệnh nhân uống nước đầy đủ và vệ mặt lâm sàng cẩn thận đối, đánh giá chức năng thận khi bắt đầu điều trị kết hợp và đánh giá theo định kỳ sau đó.

Trong một nghiên cứu lâm sàng kéo dài 28 ngày ở bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn I và II đối chứng bằng lisinopril, kết quả của việc sử dụng celecoxib 200 mg hai lần mỗi ngày cho thấy huyết áp tâm thu hoặc tâm trương trung bình hàng ngày, được xác định bằng phương pháp theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ, không tăng có ý nghĩa về mặt lâm sàng khi so sánh với điều trị bằng giả được. Trong số bệnh nhân được điều trị bằng celecoxib 200 mg x 2 lần/ngày, 48% được coi là không đáp ứng với lisinopril tại lần khám cuối cùng (được xác định huyết áp tâm trương > 90 mmHg hoặc huyết áp tâm trương tăng > 10% so với mức chuẩn), so với 27% ở bệnh nhân được điều trị bằng giả được; sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê.

Ciclosporin và tacrolimus

Dùng đồng thời NSAID và ciclosporin hoặc tacrolimus có thể làm tăng tác dụng gây độc cho thận của ciclosporin hoặc tacrolimus. Chức năng thận nên được theo dõi khi celecoxib và bất kỳ sản phẩm thuốc nào dùng phối hợp.

Acid acetylsalicylic

Celecoxib là chất ức chế được sử dụng với acid acetylsalicylic liều thấp nhưng không phải là một chất thay thế cho acid acetylsalicylic trong điều trị dự phòng tim mạch. Trong các nghiên cứu đã biết, như với các NSAID khác, dùng đồng thời celecoxib với acid acetylsalicylic liều thấp tăng nguy cơ loét đường tiêu hóa hoặc các biến chứng đường tiêu hóa so với sử dụng celecoxib đơn thuần.

Tương tác được động học

Ảnh hưởng của celecoxib đối với các thuốc khác

Ức chế CYP2D6

Celecoxib là chất ức chế CYP2D6. Nồng độ huyết tương của các thuốc là cơ chất của enzym này có thể tăng lên khi sử dụng đồng thời với celecoxib. Ví dụ về các thuốc được chuyển hóa bởi CYP2D6 là thuốc chống trầm cảm (tricyclics và SSRIs), thuốc an thần kinh, thuốc chống loạn nhịp, vv... Liều lượng của các chất CYP2D6 cho từng bệnh nhân có thể cần giảm khi bắt đầu điều trị bằng celecoxib hoặc tăng lên nếu ngừng điều trị bằng celecoxib.

Dùng đồng thời celecoxib 200 mg hai lần mỗi ngày dẫn đến tăng gấp 2,6 lần và 1,5 lần nồng độ trung huyết tương của dextromethorphan và metoprolol (cơ chất CYP2D6), tương ứng. Sự gia tăng này là do ức chế celecoxib của sự trao đổi cơ chất CYP2D6.

Ức chế CYP2C19

Trong các nghiên cứu *in vitro* đã cho thấy một số tiềm năng cho celecoxib ức chế chuyển hóa xúc tác CYP2C19. Ý nghĩa lâm sàng của phát hiện *in vitro* này chưa rõ. Ví dụ về các thuốc được chuyển hóa bởi CYP2C19 là diazepam, citalopram và imipramin.

Methotrexat

Ở những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp celecoxib không có ảnh hưởng đáng kể về mặt thống kê về được động học (độ thanh thải huyết tương hoặc thân) của methotrexat (ở liều thấp khớp). Tuy nhiên, cần phải cân nhắc việc theo dõi đầy đủ độc tính liên quan đến methotrexat khi kết hợp hai sản phẩm thuốc này.

Lithi

Ở những đối tượng khỏe mạnh, dùng phối hợp celecoxib 200 mg x 2 lần/ngày với lithi liều 450 mg x 2 lần/ngày, kết quả là mức tăng trung bình của lithi C_{max} là 16% và AUC là 18%. Vì vậy, bệnh nhân đang điều trị bằng lithi nên được theo dõi chặt chẽ khi dùng celecoxib hoặc ngừng dùng celecoxib.

Thuốc tránh thai đường uống

Trong một nghiên cứu tương tác, celecoxib không có tác dụng lâm sàng liên quan đến được động học của thuốc tránh thai (1 mg norethisteron/35 microgram ethinylestradiol).

Glibenclamid/tolbutamid

Celecoxib không ảnh hưởng đến được động học của tolbutamid (cơ chất CYP2C9), hoặc glibenclamid ở mức độ phù hợp lâm sàng.

Ảnh hưởng của các thuốc khác trên celecoxib

Những người chuyển hóa kém qua CYP2C9

Ở những người chuyển hóa kém qua CYP2C9 và cho thấy tăng tiếp xúc toàn thân với celecoxib, điều trị đồng thời với các chất ức chế CYP2C9 như fluconazol có thể dẫn đến tăng tiếp xúc với celecoxib. Các kết hợp như vậy nên tránh ở những người chuyển hóa kém qua CYP2C9 đã biết.

Chất ức chế CYP2C9 và chất cảm ứng

Vì celecoxib chủ yếu được chuyển hóa bởi CYP2C9, nên sử dụng một nửa liều khuyến cáo ở những bệnh nhân dùng fluconazol. Sử dụng đồng thời đơn liều 200 mg celecoxib và 200 mg fluconazol một lần mỗi ngày, đây là một chất ức chế CYP2C9 mạnh, dẫn đến tăng trung bình celecoxib C_{max} là 60% và AUC là 130%. Sử dụng đồng thời các chất gây cảm ứng CYP2C9 như rifampicin, carbamazepin và barbiturat có thể làm giảm nồng độ celecoxib trong huyết tương.

Ketoconazol và các thuốc kháng acid

Ketoconazol hoặc thuốc kháng acid đã không được quan sát thấy ảnh hưởng đến được động học của celecoxib.

Trẻ em

Các nghiên cứu tương tác chỉ được thực hiện ở người lớn.

Tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn:

Các phản ứng có hại được phân nhóm theo tần suất: Rất thường gặp (ADR ≥ 1/10), thường gặp (1/100 ≤ ADR < 1/10), ít gặp (1/1.000 ≤ ADR < 1/100), hiếm gặp (1/10.000 ≤ ADR < 1/1.000), rất hiếm gặp (ADR < 1/10.000); không thể ước lượng tần suất được liệt kê "Chưa rõ tần suất".

Tác dụng không mong muốn của celecoxib ở liều thường dùng nói chung nhẹ và có liên quan chủ yếu đến đường tiêu hóa. Những tác dụng không mong muốn khiến phải ngừng dùng thuốc nhiều nhất gồm: Khó tiêu, đau bụng, cần lưu ý nguy cơ huyết khối tim mạch (xem thêm phần Cảnh báo và thận trọng).

Rối thường gặp

Rối loạn mạch máu: Tăng huyết áp (bao gồm tăng huyết áp nặng hơn).

Thường gặp

Nhiễm trùng và nhiễm ký sinh trùng: Viêm xoang, nhiễm trùng đường hô hấp trên, viêm họng, nhiễm trùng đường tiết niệu.

Rối loạn tiêu hóa: Buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi, nôn, khó nuốt.

Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất: Viêm mũi, ho, khó thở.

Rối loạn tâm thần: Mất ngủ.

Rối loạn thần kinh: Chóng mặt, tăng trương lực cơ, nhức đầu.

Rối loạn da và mô dưới da: Phát ban, ngứa (bao gồm ngứa toàn thân).

Rối loạn tim mạch: Nhồi máu cơ tim.

Rối loạn hệ miễn dịch: Quá mẫn.

Rối loạn cơ xương và mô liên kết: Đau khớp.

Rối loạn toàn thân và tại chỗ: Bệnh giống cúm, phù ngoại biên/giữ nước.

Tổn thương, nhiễm độc và tình trạng do thủ thuật: Tổn thương.

Ít gặp

Rối loạn tiêu hóa: Táo bón, viêm dạ dày, viêm miệng, viêm đường tiêu hóa (bao gồm cả viêm đường tiêu hóa nặng hơn), ợ hơi.

Rối loạn gan mật: Chức năng gan bất thường, men gan tăng (bao gồm tăng SGOT và SGPT).

Rối loạn tâm thần: Lo lắng, trầm cảm, mệt mỏi.

Rối loạn hệ thần kinh: Nhồi máu não, dị cảm, buồn ngủ.

Đối tượng đặc biệt
Tâm nhĩ bị mờ, viêm kết mạc.

Prescription drug
Read carefully the instructions before use
Keep out of reach of children

Formula for 1 capsule:

Active ingredient:
Each AgileCOX 200 capsule contains 200 mg Celecoxib.
Excipients:
Lactose monohydrate, Povidone K30, Sodium lauryl sulfate, Magnesium stearate.

Pharmaceutical dosage form: White cap and white body, size "2" hard capsules, with one gold band on cap and one on body, filled with non-cohesive white powder.

Indications:

Celecoxib is indicated in adults for the symptomatic relief in the treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis.
The decision to prescribe a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor should be based on an assessment of the individual patient's overall risks (see Contraindications and Warnings and precautions for use).

Dosage, administration:

Administration: Oral use.
Dose up to 200 mg twice daily can be taken without regard to timing of meals, higher doses (400 mg twice daily) should be taken with food to improve the absorption.
Dosage: For adults.

As the cardiovascular (CV) risks of celecoxib may increase with dose and duration of exposure, the shortest duration possible and the lowest effective daily dose should be used. The patient's need for response to therapy should be re-evaluated periodically, especially in patients with osteoarthritis.

Osteoarthritis:

The usual recommended daily dose is 200 mg taken once daily. In some patients, with insufficient relief from symptoms, an increased dose of 200 mg twice daily may be given. In the absence of an increase in therapeutic benefit after two weeks, other therapeutic options should be considered.

Rheumatoid arthritis:

The initial recommended daily dose is 200 mg taken once daily. The dose may, if needed, later be increased to 200 mg twice daily. In the absence of an increase in therapeutic benefit after two weeks, other therapeutic options should be considered.

Ankylosing spondylitis:

The recommended daily dose is 200 mg taken once daily. In a few patients, with insufficient relief from symptoms, an increased dose of 400 mg once daily or 200 mg twice daily may increase efficacy. In the absence of an increase in therapeutic benefit after two weeks, other therapeutic options should be considered.
The maximum recommended daily dose is 400 mg for all indications.

Special populations:

Elderly:

As in adults, 200 mg per day should be used initially. The dose may, if needed, later be increased to 200 mg twice daily. Particular caution should be exercised in elderly with a body weight less than 50 kg.

Paediatric population:

Celecoxib is not indicated for use in children.

CYP2C9 poor metabolisers:

Patients who are known or suspected to be CYP2C9 poor metabolisers based on previous history/experience with other CYP2C9 substrates should be administered celecoxib with caution as the risk of dose-dependent adverse effects is increased. Consider reducing the dose to half the lowest recommended dose.

Hepatic impairment:

Treatment should be initiated at half the recommended dose in patients with established liver impairment with a serum albumin of 25–35 g/l. Experience in such patients is limited to cirrhotic patients.

Renal impairment:

Experience with celecoxib in patients with mild or moderate renal impairment is limited, therefore such patients should be treated with caution.

Some special attention on the handling of the medicine before and after use:

There are no special requirements for handling this medicine after use.

Contraindications:

Hypersensitivity to celecoxib or sulfonamide or to any of the excipients of the medicine.
Suffering from active peptic ulceration or gastrointestinal (GI) bleeding.
History of asthma, urticaria, or other allergic-type reactions after taking aspirin or other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) including COX-2 inhibitors.
In pregnancy and in women of childbearing potential unless using an effective method of contraception.
Celecoxib has been shown to cause malformations in the two animal species studied. The potential for human risk in pregnancy is unknown, but cannot be excluded.
Breast-feeding mothers.
Severe hepatic dysfunction (serum albumin < 25 g/l or Child-Pugh score ≥ 10).
Patients with estimated creatinine clearance < 30 ml/min.
Inflammatory bowel disease.
Congestive heart failure (NYHA II–IV).
Established ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and/or cerebrovascular disease.

Warnings and precautions for use:

Gastrointestinal (GI) effects:

Upper and lower gastrointestinal complications [perforations, ulcers or bleedings (PUBs)], some of them resulting in fatal outcome, have occurred in patients treated with celecoxib. Caution is advised with treatment of patients most at risk of developing a gastrointestinal complication with NSAIDs such as the elderly, patients using any other NSAID or acetylsalicylic acid or glucocorticoids concomitantly, patients using alcohol, or patients with a prior history of gastrointestinal disease, such as ulceration and GI bleeding.

There is further increase in the risk of gastrointestinal adverse effects for celecoxib (gastrointestinal ulceration or other gastrointestinal complications), when celecoxib is taken concomitantly with acetylsalicylic acid (even at low doses). A significant difference in GI safety between selective COX-2 inhibitors + acetylsalicylic acid vs. NSAIDs + acetylsalicylic acid has not been demonstrated in long-term clinical trials.

Concomitant NSAID use:

The concomitant use of celecoxib and a non-aspirin NSAID should be avoided.

Cardiovascular effects:

Risk of cardiovascular thrombosis:

Celecoxib may increase the risk of serious cardiovascular thrombosis, myocardial infarction, and stroke, which can be fatal. Systemic nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), except aspirin may increase the risk of developing cardiovascular thrombotic events, including myocardial infarction and stroke, which can lead to death. This risk may occur early in the first few weeks of treatment and may increase with longer use of the NSAID. Risk of cardiovascular thrombosis was mainly recorded at high doses.

Doctors should periodically assess the occurrence of cardiovascular events, even if the patient has no previous cardiac symptoms. Patients should be warned about the symptoms of serious cardiovascular events and should see a doctor as soon as these symptoms appear.

elderly. Patients should be adequately hydrated and consideration should be given to monitoring of renal function after initiation of concomitant therapy, and periodically thereafter.

In a 28-day clinical study in patients with lisinopril-controlled stage I and II hypertension, administration of celecoxib 200 mg twice daily resulted in no clinically significant increases, when compared to placebo treatment, in mean daily systolic or diastolic blood pressure as determined using 24-hour ambulatory blood pressure monitoring. Among patients treated with celecoxib 200 mg twice daily, 48% were considered unresponsive to lisinopril at the final clinic visit (defined as either cuff diastolic blood pressure > 90 mmHg or cuff diastolic blood pressure increased > 10% compared to baseline), compared to 27% of patients treated with placebo; this difference was statistically significant.

Ciclosporin and tacrolimus:

Co-administration of NSAIDs and ciclosporin or tacrolimus may increase the nephrotoxic effect of ciclosporin or tacrolimus, respectively. Renal function should be monitored when celecoxib and any of these medicinal products are combined.

Acetylsalicylic acid:

Celecoxib is an inhibitor of CYP2D6. The plasma concentrations of medicinal products that are substrates of this enzyme may be increased when celecoxib is used concomitantly. Examples of medicinal products which are metabolised by CYP2D6 are antidepressants (tricyclics and SSRIs), neuroleptics, anti-arrhythmic medicinal products, etc. The dose of individually dose-titrated CYP2D6 substrates may need to be reduced when treatment with celecoxib is initiated or increased if treatment with celecoxib is terminated.

Pharmacokinetic interactions:

Effects of celecoxib on other medicinal products:

CYP2D6 inhibition:

Celecoxib is an inhibitor of CYP2D6. The plasma concentrations of medicinal products that are substrates of this enzyme may be increased when celecoxib is used concomitantly. Examples of medicinal products which are metabolised by CYP2D6 are antidepressants (tricyclics and SSRIs), neuroleptics, anti-arrhythmic medicinal products, etc. The dose of individually dose-titrated CYP2D6 substrates may need to be reduced when treatment with celecoxib is initiated or increased if treatment with celecoxib is terminated.

CYP2C19 inhibition:

In vitro studies have shown some potential for celecoxib to inhibit CYP2C19 catalysed metabolism. The clinical significance of this in vitro finding is unknown. Examples of medicinal products which are metabolised by CYP2C19 are diazepam, citalopram and imipramine.

Methotrexate:

In patients with rheumatoid arthritis celecoxib had no statistically significant effect on the pharmacokinetics (plasma or renal clearance) of methotrexate (in rheumatologic doses). However, adequate monitoring for methotrexate-related toxicity should be considered when combining these two drugs.

Lithium:

In healthy subjects, co-administration of celecoxib 200 mg twice daily with 450 mg twice daily of lithium resulted in a mean increase in C_{max} of 16% and in AUC of 18% of lithium. Therefore, patients on lithium treatment should be closely monitored when celecoxib is introduced or withdrawn.

Oral contraceptives:

In an interaction study, celecoxib had no clinically relevant effects on the pharmacokinetics of oral contraceptives (1 mg norethisterone/35 micrograms ethinylestradiol).

Glibenclamide/tolbutamide:

Celecoxib does not affect the pharmacokinetics of tolbutamide (CYP2C9 substrate), or glibenclamide to a clinically relevant extent.

Effects of other medicinal products on celecoxib:

CYP2C9 poor metabolisers:

In individuals who are CYP2C9 poor metabolisers and demonstrate increased systemic exposure to celecoxib, concomitant treatment with CYP2C9 inhibitors such as fluconazole could result in further increases in celecoxib exposure. Such combinations should be avoided in known CYP2C9 poor metabolisers.

CYP2C9 inhibitors and inducers:

Since celecoxib is predominantly metabolised by CYP2C9 it should be used at half the recommended dose in patients receiving fluconazole. Concomitant use of 200 mg single dose of celecoxib and 200 mg once daily of fluconazole, a potent CYP2C9 inhibitor, resulted in a mean increase in celecoxib C_{max} of 60% and in AUC of 130%. Concomitant use of inducers of CYP2C9 such as rifampicin, carbamazepine and barbiturates may reduce plasma concentrations of celecoxib.

Ketoconazole and antacids:

Ketoconazole or antacids have not been observed to affect the pharmacokinetics of celecoxib.

Children:

Interaction studies have only been performed in adults.

Incompatibilities:

Because there are no studies of drug incompatibility, do not mix this drug with other drugs.

Undesirable effects:

Side effects are classified according to frequency: Very common (ADR ≥ 1/10), common (1/100 ≤ ADR < 1/10), uncommon (1/1,000 ≤ ADR < 1/100), rare (1/10,000 ≤ ADR < 1/1,000), very rare (ADR < 1/10,000); cannot be estimated from the available data "Not known".

In general, undesirable effects of celecoxib at usual doses are mild and primarily relevant to GI tract. Adverse reactions which mostly lead to discontinuing the drug include dyspepsia, abdominal pain. Attention should be paid to the risk of cardiovascular thromboembolism (see Warnings and precautions for use).

Very common:

Vascular disorders: Hypertension (including aggravated hypertension).

Common:

Infections and infestations: Sinusitis, upper respiratory tract infection, pharyngitis, urinary tract infection.

Gastrointestinal disorders: Nausea, abdominal pain, diarrhoea, dyspepsia, flatulence, vomiting, dysphagia.

Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders: Rhinitis, cough, dyspnoea.

Psychiatric disorders: Insomnia.

Nervous system disorders: Dizziness, hypertonía, headache.

Skin and subcutaneous tissue disorders: Rash, pruritus (includes pruritus generalised).

Cardiac disorders: Myocardial infarction.

Immune system disorders: Hypersensitivity.

Musculoskeletal and connective tissue disorders: Arthralgia.

General disorders and administrative site conditions: Influenza-like illness, oedema peripheral/ fluid retention.

Injury, poisoning and procedural complications: Injury.

Uncommon:

Gastrointestinal disorders: Constipation, gastritis, stomatitis, gastrointestinal inflammation (including aggravation of gastrointestinal inflammation), eructation.

Hepatobiliary disorders: Hepatic function abnormal, hepatic enzyme increased (including increased SGOT and SGPT).

Psychiatric disorders: Anxiety, depression, fatigue.

Nervous system disorders: Cerebral infarction, paraesthesia, somnolence.

Eye disorders: Vision blurred, conjunctivitis.

Risk of cardiovascular thrombosis:

Celecoxib may increase the risk of serious cardiovascular thrombosis, myocardial infarction, and stroke, which can be fatal. Systemic nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), except aspirin may increase the risk of developing cardiovascular thrombotic events, including myocardial infarction and stroke, which can lead to death. This risk may occur early in the first few weeks of treatment and may increase with longer use of the NSAID. Risk of cardiovascular thrombosis was mainly recorded at high doses.

Doctors should periodically assess the occurrence of cardiovascular events, even if the patient has no previous cardiac symptoms. Patients should be warned about the symptoms of serious cardiovascular events and should see a doctor as soon as these symptoms appear.

To minimize the risk of adverse events, AGILECOX 200 should be used at the lowest effective daily dose for the shortest possible duration.

The patient's need for response to therapy should be re-evaluated periodically, especially in patients with osteoarthritis. Patients with significant risk factors for cardiovascular events (e.g. hypertension, hyperlipidaemia, diabetes mellitus, smoking) should only be treated with celecoxib after careful consideration.

COX-2 selective inhibitors are not a substitute for acetylsalicylic acid for prophylaxis of cardiovascular thrombo-embolic diseases because of their lack of antiplatelet effects. Therefore, antiplatelet therapies should not be discontinued.

Fluid retention and oedema:

As with all medicinal products known to inhibit prostaglandin synthesis, fluid retention and oedema have been observed in patients taking celecoxib. Therefore, celecoxib should be used with caution in patients with history of cardiac failure, left ventricular dysfunction or hypertension, and in patients with pre-existing oedema from any other reason, since prostaglandin inhibition may result in deterioration of renal function and fluid retention. Caution is required in patients taking diuretic treatment or otherwise at risk of hypovolaemia.

Hypertension:

As with all NSAIDs, celecoxib can lead to the onset of new hypertension or worsening of pre-existing hypertension, either of which may contribute to the increased incidence of cardiovascular events. Therefore, blood pressure should be monitored closely during the initiation of therapy with celecoxib and throughout the course of therapy.

Hepatic and renal effects:

Compromised renal or hepatic function and especially cardiac dysfunction are more likely in the elderly and therefore medically appropriate supervision should be maintained.

NSAIDs, including celecoxib, may cause renal toxicity. Clinical trials with celecoxib have shown renal effects similar to those observed with comparator NSAIDs. Patients at greatest risk for renal toxicity are those with impaired renal function, heart failure, liver dysfunction, those taking diuretics, ACE-inhibitors, angiotensin II receptor antagonists, and the elderly. Such patients should be carefully monitored while receiving treatment with celecoxib.

Some cases of severe hepatic reactions, including fulminant hepatitis (some with fatal outcome), liver necrosis and, hepatic failure (some with fatal outcome or requiring liver transplant), have been reported with celecoxib. Among the cases that reported time to onset, most of the severe adverse hepatic events developed within one month after initiation of celecoxib treatment.

If during treatment, patients deteriorate in any of the organ system functions described above, appropriate measures should be taken and discontinuation of celecoxib therapy should be considered.

CYP2D6 inhibition:

Celecoxib inhibits CYP2D6. The dose of individually dose-titrated medicinal products that are metabolised by CYP2D6 may need to be reduced when treatment with celecoxib is initiated or increased if treatment with celecoxib is terminated.

CYP2C9 poor metabolisers:

Patients known to be CYP2C9 poor metabolisers should be treated with caution.

Skin and systemic hypersensitivity reactions:

Serious skin reactions, some of them fatal, including exfoliative dermatitis, Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis, have been reported very rarely in association with the use of celecoxib. Patients appear to be at high risk for these reactions early in the course of therapy. The onset of the reaction occurring in the majority of cases within the first month of treatment. Serious hypersensitivity reactions (including anaphylaxis, angioedema and drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS), or hypersensitivity syndrome), have been reported in patients receiving celecoxib (see Undesirable effects). Patients with a history of sulfonamide allergy or any drug allergy may be at greater risk of serious skin reactions or hypersensitivity reactions.

Celecoxib should be discontinued at the first appearance of skin rash, mucosal lesions, or any other sign of hypersensitivity.

General: Celecoxib may mask fever and other signs of inflammation.

Use with oral anticoagulants:

In patients on concurrent therapy with warfarin, serious bleeding events, some of them fatal, have been reported. Increased prothrombin time (INR) with concurrent therapy has been reported. Therefore, this should be closely monitored in patients receiving warfarin/coumarin-type oral anticoagulants, particularly when therapy with celecoxib is initiated or celecoxib dose is changed (see Interactions). Concomitant use of anticoagulants with NSAIDs may increase the risk of bleeding. Caution should be exercised when combining celecoxib with warfarin or other oral anticoagulants, including novel anticoagulants (e.g. apixaban, dabigatran, and rivaroxaban).

This drug contains lactose: Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine.

Pregnancy and lactation:

Pregnancy:

Studies in animals (rats and rabbits) have shown reproductive toxicity, including malformations. Inhibition of prostaglandin synthesis might adversely affect pregnancy. Data from epidemiological studies suggest an increased risk of spontaneous abortion after use of prostaglandin synthesis inhibitors in early pregnancy. The potential for human risk in pregnancy is unknown, but cannot be excluded. Celecoxib, as with other medicinal products inhibiting prostaglandin synthesis, may cause uterine inertia and premature closure of the ductus arteriosus during the last trimester.

During the second or third trimester of pregnancy, NSAIDs including celecoxib may cause fetal renal dysfunction which may result in reduction of amniotic fluid volume or oligohydramnios in severe cases. Such effects may occur shortly after treatment initiation and are usually reversible.

Celecoxib is contraindicated in pregnancy and in women who can become pregnant. If a woman becomes pregnant during treatment, celecoxib should be discontinued.

Women who have potential for pregnancy or are using birth control measures should consult a physician before receiving the treatment with this medicine.

Lactation:

Celecoxib is excreted in the milk of lactating rats at concentrations similar to those in plasma. Administration of celecoxib to a limited number of lactating women has shown a very low transfer of celecoxib into breast milk. Women who take celecoxib should not breastfeed.

Effects on ability to drive and use machines:

Caution should be considered when driving motor vehicles or operating machines because AGILECOX 200 may cause headache, dizziness.

Interactions, Incompatibilities of medicine:

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction:

Pharmacodynamic interactions:

Anticoagulants:

Anticoagulant activity should be monitored particularly in the first few days after initiating or changing the dose of celecoxib in patients receiving warfarin or other anticoagulants since these patients have an increased risk of bleeding complications. Therefore, patients receiving oral anticoagulants should be closely monitored for their prothrombin time INR, particularly in the first few days when therapy with celecoxib is initiated or the dose of celecoxib is changed. Bleeding events in association with increases in prothrombin time have been reported, predominantly in the elderly, in patients receiving celecoxib concurrently with warfarin, some of them fatal.

Anti-hypertensives:

NSAIDs may reduce the effect of anti-hypertensive medicinal products including ACE-inhibitors, angiotensin II receptor antagonists, diuretics and beta-blockers. As for NSAIDs, the risk of acute renal insufficiency, which is usually reversible, may be increased in some patients with compromised renal function (e.g. dehydrated patients, patients on diuretics or elderly patients) when ACE inhibitors or angiotensin II receptor antagonists, and/or diuretics are combined with NSAIDs, including celecoxib. Therefore, the combination should be administered with caution, especially in the

elderly.

Uncommon:

Gastrointestinal disorders: Constipation, gastritis, stomatitis, gastrointestinal inflammation (including aggravation of gastrointestinal inflammation), eructation.

Hepatobiliary disorders: Hepatic function abnormal, hepatic enzyme increased (including increased SGOT and SGPT).

Psychiatric disorders: Anxiety, depression, fatigue.

Nervous system disorders: Cerebral infarction, paraesthesia, somnolence.

Eye disorders: Vision blurred, conjunctivitis.

Ear and labyrinth disorders: Tinnitus, hypacusis.

Cardiac disorders: Cardiac failure, palpitations, tachycardia.

Blood and lymphatic system disorders: Anemia.

Metabolism and nutrition disorders: Hyperkalaemia.

Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders: Bronchospasm.

Skin and subcutaneous tissue disorders: Urticaria, ecchymosis.

Musculoskeletal and connective tissue disorders: Muscle spasms (leg cramps).

Renal and urinary disorders: Blood creatinine increased, blood urea increased.

General disorders and administrative site conditions: Face oedema, chest pain.

Rare:

Cardiac disorders: Syncope, congestive heart failure, ventricular fibrillation, pulmonary embolism, cerebral vascular accident, peripheral gangrene, thrombophlebitis, cellulitis, arrhythmia.

Vascular disorders: Pulmonary embolism, flushing.

Eye disorders: Eye haemorrhage.

Gastrointestinal disorders: Gastro-intestinal haemorrhage, duodenal ulcer, gastric ulcer, oesophageal ulcer, intestinal ulcer, large intestinal ulcer, intestinal perforation; oesophagitis, melana; pancreatitis, colitis.

Hepatobiliary disorders: Hepatitis.

Blood and lymphatic system disorders: Leucopenia, thrombocytopenia.

Psychiatric disorders: Confusional state, hallucinations.

Nervous system disorders: Ataxia, dysgeusia.

Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders: Pneumonitis.

Renal and urinary disorders: Renal failure acute, hypo-natraemia.

Skin and subcutaneous tissue disorders: Angioedema, alopecia, photo-sensitivity.

Reproductive system and breast disorders: Menstrual disorder.

Very rare:

Immune system disorders: Anaphylactic reaction.

Nervous system disorders: Haemorrhage intracranial (including fatal intracranial haemorrhage), meningitis aseptic, epilepsy (including aggravated epilepsy), ageusia, anosmia.

Vascular disorders: Vasculitis.

Blood and lymphatic system disorders: Pancytopenia.

Eye disorders: Retinal artery occlusion, retinal vein occlusion.

Hepatobiliary disorders: Hepatic failure (sometimes fatal or requiring liver transplant), hepatitis fulminant (some with fatal outcome), hepatic necrosis, cholestasis, hepatitis cholestatic, jaundice.

Skin and subcutaneous tissue disorders: Dermatitis exfoliative, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS), acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP), dermatitis bullosa.

Musculoskeletal and connective tissue disorders: Myositis.

Renal and urinary disorders: Tubulo interstitial nephritis, nephrotic syndrome, glomerulonephritis minimal lesion.

Not known:

Reproductive system and breast disorders: Infertility female (female fertility decreased).

(Women intending to become pregnant are excluded from all trials, thus consultation of the trial database for the frequency of this event was not reasonable).

Overdose and management:

Overdose:

Overdose of nonsteroidal anti-inflammatory drug can cause lethargy, drowsiness, nausea, vomiting, and epigastric pain, which are generally reversible with supportive care. Gastrointestinal bleeding can occur. Rare symptoms including hypertension, acute renal failure, respiratory depression and coma were reported. Anaphylactic reactions have been reported with therapeutic dose of nonsteroidal anti-inflammatory drug and may occur following an overdose.

Management:

There is no specific antidote to the nonsteroidal anti-inflammatory drug. The treatment includes symptomatic and supportive care. Within 4 hours after overdosing, induction of emesis and/or oral activated charcoal (60 - 100 g for adults, or 1 to 2 g/kg for children), and/or an osmotic cathartic can be useful in patients who had pathologic manifestations or ingested a large overdose. Hemodialysis is not effective in eliminating the medicine from the body.

Pharmacodynamics:

Pharmacotherapeutic group: Antiinflammatory and antirheumatic products, non-steroids -Coxibs.

ATC code: M01AH01.

Celecoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic effects.

The mechanism of celecoxib action is believed to be due to inhibition of prostaglandin synthesis primarily via the inhibition of cyclooxygenase-2 (COX-2) isoenzyme that results in reducing the formation of prostaglandin precursor.

Unlike traditional NSAIDs, celecoxib does not inhibit cyclooxygenase-1 (COX-1) isoenzyme at human therapeutic concentrations. COX-1 is known as an enzyme present in most tissues, macrophocyte and platelets.

COX-1 involves in blood-clot formation (promoting platelet aggregation), maintains gastric mucosal barrier integrity and kidney function (as renal blood flow).

Because celecoxib does not inhibit COX-1, it is less likely to cause side effects (for example: effects on platelets and gastric mucosa). However, celecoxib may cause renal side effects similar to non-selective NSAIDs.

Pharmacokinetics:

Absorption: Celecoxib is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract. When celecoxib is taken with a high fat meal, peak plasma levels were delayed for about 1 to 2 hours, compared without food, with an increase in AUC of 10% to 20%. Celecoxib can be given without regard to timing of meals.

Peak plasma concentration is reached 3 hours after an oral single dose of 200 mg without food and average value is 705 ng/ml. Plasma concentration at steady state is achieved within 5 days, accumulation is not observed. Elderly subjects (over 65 years old) had a 40% higher Cmax and a 50% higher AUC compared to the young subjects. AUC of celecoxib at steady state increased 40% or 180% in mild to moderate hepatic failure, respectively, and decreased by 40% in patients with chronic renal failure (glomerular filtration rate 35 - 60 ml/minute), compared to subjects with normal renal function.

Distribution: Volume of distribution at steady state is about 400 liters (approximately 7.14 liters/kg). This means that celecoxib is excessively distributed into tissues. Celecoxib is bound to plasma protein by 97% within therapeutic concentrations.

Metabolism, elimination: After oral administration, the plasma elimination half - life is about 11 hours. The plasma clearance is about 500 ml/min. Celecoxib half - life is prolonged in patients with renal or hepatic failure. Celecoxib is metabolized in the liver to inactive metabolites by isoenzyme CYP450 2C9.

Approximately 57% is excreted in feces and 27% in urine, less than 3% of dose is excreted unchanged.

Packing:

1-bottle box x 100 capsules.

2/3/4/6/10/12/15/20-blisters box x 10 capsules.

Storage conditions, shelf life, quality specification of the medicine:

Storage conditions: Protect from humidity and light, below 30°C.

Shelf life: 36 months from the manufacture date.

Quality specification: In house.

Name, address of manufacturer:

 **Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company**
27 Nguyen Thai Hoc Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Manufactured by: Branch of Agimexpharm Pharmaceutical JSC. - Agimexpharm Pharmaceutical Factory
Vu Trong Phung Street, Thanh An Hamlet, My Tho Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Telephone: (+84) 2963 857300 Fax: (+84) 2963 857301

A1203007302